CENTRO CLINICO SINTETICO - DOCUMENTO DI PROVA
REFERTO CARDIOLOGICO

Paziente: Sintetico047 Persona047 - Nato il 1952-03-12
Codice fiscale paziente: ZZZXXX47A21Z999D
Data referto: 07/10/2026

MOTIVO DELL'ACCESSO
Motivo: controllo per palpitazioni episodiche. I sintomi sono riferiti da circa tre settimane; il paziente viene ascoltato prima del colloquio con il familiare accompagnatore.

INQUADRAMENTO CLINICO
La valutazione complessiva conferma ipertensione arteriosa tra le condizioni personali rilevanti.

INQUADRAMENTO CLINICO
La valutazione complessiva conferma dislipidemia tra le condizioni personali rilevanti.

ANAMNESI FAMILIARE
Per il familiare indicato come madre viene riferita ipertensione arteriosa; questa informazione appartiene all'anamnesi familiare.

TERAPIA FARMACOLOGICA
Alla visita risulta in uso Triatec (ramipril) 5 mg, 1 cp alla sera per os.

TERAPIA FARMACOLOGICA
È stata sospesa la somministrazione di Norvasc (amlodipina) 5 mg, 1 cp al giorno. La sospensione è stata confermata durante il colloquio odierno.

RICOGNIZIONE TERAPEUTICA
Il paziente non assume Coumadin (warfarin); il nome compare soltanto nel questionario di riconciliazione.

IPOTESI NON ATTUATA
Si propone eventualmente Lyrica (pregabalin) 25 mg alla sera, ma la terapia non è stata iniziata e resta da discutere.

DATI DEL CAREGIVER
Il coniuge assume Eutirox (levotiroxina) 50 microgrammi al giorno; questa terapia non riguarda il paziente.

ESCLUSIONI
Non vi sono elementi per porre diagnosi di polmonite batterica in questa visita.

INQUADRAMENTO CLINICO
Resta il sospetto di neuropatia periferica, da confermare con gli accertamenti successivi.

Firma: dott. Medico Esempio - firma simulata, priva di valore.

Paziente: Sintetico047 Persona047 - Nato il 1952-03-12
Codice fiscale paziente: ZZZXXX47A21Z999D
Data referto: 07/10/2026

CONTESTO ASSISTENZIALE

La persona vive al domicilio con il coniuge, che prepara il portapillole settimanale; il paziente assume poi i farmaci autonomamente.

CONCLUSIONI E INDICAZIONI

È richiesto un controllo ambulatoriale tra due settimane, con diario dei sintomi e confezioni dei farmaci. La data del prossimo appuntamento non è ancora fissata.

MODALITÀ DELLA RACCOLTA DOCUMENTALE

Il colloquio è stato svolto in un ambiente tranquillo, lasciando inizialmente spazio al racconto spontaneo e successivamente verificando gli elementi della documentazione. Quando il racconto e la lista dei medicinali non coincidevano, la discrepanza è stata mantenuta visibile nella sezione della ricognizione. Il documento distingue le condizioni già note dalle ipotesi che richiedono ulteriori accertamenti. I dati forniti dall’accompagnatore sono identificati come tali e non vengono assunti come storia patologica del paziente. Le abbreviazioni cp, os e MMG sono utilizzate rispettivamente per compressa, via orale e medico di medicina generale. Il resoconto deve essere letto insieme alle indicazioni poste nelle conclusioni e alle date degli eventi, senza attribuire a oggi ogni notizia riportata in anamnesi.

RIFERIMENTO DI EMISSIONE

Emissione sintetica 148971. Copia per il medico curante; conservare tutte le pagine del documento.

Firma: dott. Medico Esempio - firma simulata, priva di valore.